

TENDINOPATIA ŚCIĘGNA ACHILLESA

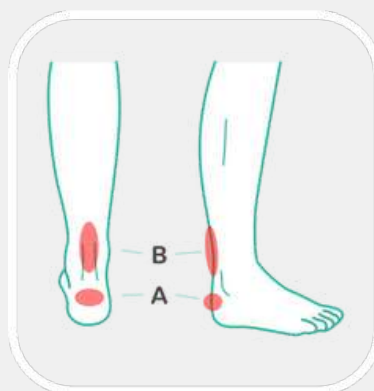
Czym jest i wskazówki dotyczące jej leczenia

Czym jest tendinopatia ścięgna Achillesa?

Ścięgno Achillesa, znane również jako „ścięgno piętowe”, znajduje się z tyłu kostki (**ramka 1**). Tendinopatię definiuje się jako miejscowy ból ścięgna związany z obciążającymi czynnościami.

Tendinopatia ścięgna Achillesa często prowadzi do bólu oraz obniżenia funkcji i tolerancji na wysiłek. Może również wywoływać rozproszony lub miejscowy obrzęk, a także sztywność i ból po odpoczynku, na przykład rano lub po długotrwałym siedzeniu.

W początkowej fazie objawy mogą się zmniejszyć lub nawet ustąpić po wykonaniu niewielkiego ruchu, jednak w późniejszym stadium tendinopatii mogą stać się bardziej ograniczające i powodować przewlekły ból podczas aktywności.



Rycina 1. Tendinopatia ścięgna Achillesa jest

często dzielone na dwa stany:
A) tendinopatia wstawkowa, B)
tendinopatia środkowa.

Ramka 1. Ścięgno Achillesa

- Jest to wytrzymały, włóknisty sznur łączący mięśnie łydki z kością piętową.
- Stanowi najgrubsze ścięgno w ciele człowieka.
- Przenosi siły generowane przez skurcz mięśni łydki, co prowadzi do wyprostu kostki.
- Musi wielokrotnie znosić i przenosić znaczne obciążenia, aby umożliwić wykonywanie codziennych czynności oraz uprawianie sportu.

Skąd się wzięła?

Choć tradycyjnie za czynniki ryzyka tendinopatii ścięgna Achillesa uznaje się wiele elementów, w tym biomechanikę, genetykę, inne problemy zdrowotne oraz zmiany strukturalne ścięgna (widoczne w badaniach obrazowych), dokładna patofizjologia i czynniki ryzyka wciąż pozostają nieznane.

Wiadomo jednak, że ten stan nie jest spowodowany przez pojedynczy czynnik, lecz przez wiele elementów, które różnią się w zależności od osoby. Oznacza to, że prawdopodobnie nie istnieje jeden powód, dla którego rozwinęła się tendinopatia ścięgna Achillesa, lecz wiele czynników odgrywa istotną rolę.

Tendinopatia ścięgna Achillesa może być powiązana z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, takimi jak stany zapalne lub metaboliczne. Często jednak klasyfikowana jest jako uraz przeciążeniowy, co sugeruje, że rozwijała się stopniowo w wyniku powtarzających się obciążeń przekraczających wydolność ścięgna.

Nagły wzrost częstotliwości lub intensywności działań obciążających ścięgno Achillesa może zwiększać ryzyko wystąpienia tendinopatii, podobnie jak niewystarczający odpoczynek oraz regeneracja.

Oprócz przekroczenia progu obciążenia ścięgna, wcześniejsze doświadczenie tendinopatii ścięgna Achillesa oraz trening w niskich temperaturach mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia tej dolegliwości.

Warto zauważyć, że zmiany strukturalne w ścięgnię nie zawsze prowadzą do odczuwania bólu, a zmiany te są również obserwowane u osób bez objawów. Ból jest doświadczeniem sensorycznym i emocjonalnym, które pełni rolę alarmu generowanego przez układ nerwowy. Mózg interpretuje różnorodne sygnały płynące z ciała, a także inne informacje, takie jak wcześniejsze doświadczenia, przekonania i emocje. Z tego powodu różnorodne czynniki biopsychospołeczne mogą wpływać na wystąpienie bólu oraz jego czas trwania, również w kontekście tendinopatii ścięgna Achillesa.

Jak przeprowadza się diagnozę?

Rozpoznanie tendinopatii ścięgna Achillesa nie wymaga obrazowania, takiego jak prześwietlenie rentgenowskie czy rezonans magnetyczny (MRI). Zamiast tego diagnoza opiera się na objawach klinicznych, związanym z aktywnością zlokalizowanym bólu ścięgna oraz historii sztywności, a następnie weryfikowana jest poprzez palpację ścięgna w celu ustalenia, czy występuje tkiwość. Testy funkcjonalne, takie jak podskakiwanie na jednej nodze czy unoszenie pięt, mogą również pomóc w określeniu, czy ból jest wywoływany przez aktywność.

Ultrasonografia może być zastosowana w celu wykluczenia innych potencjalnych źródeł bólu.



Czego mogę oczekiwać?

Ważne jest, aby zrozumieć, że uporczywe objawy oraz zaostrzenia są normalne i powszechne. Obecnie dysponujemy ograniczoną wiedzą na temat czynników wpływających na długoterminowe rokowanie tendinopatii ścięgna Achillesa, co utrudnia określenie, jak długo objawy będą się utrzymywać.

Jedna osoba może poczuć się w pełni wyleczona w ciągu trzech miesięcy, jednak często proces ten trwa dłużej, nawet latami. Na dłuższą metę większość osób (niemal dwie trzecie) zauważy ustąpienie objawów, chociaż może to zająć czas. Mniejsza grupa (poniżej jednej trzeciej) może nadal doświadczać łagodnych objawów, lecz tylko jedna na dziesięć osób będzie miała poważniejsze ograniczenia funkcjonalne.

Zerwanie ścięgna Achillesa jest powszechnym problemem wśród osób z dolegliwościami tego ścięgna. .

Jak mogę sobie z tym radzić?

Celem leczenia tendinopatii ścięgna Achillesa jest często redukcja objawów oraz niepełnosprawności związanej z chorobą, a także wspomaganie procesu gojenia ścięgna. Wczesna interwencja może prowadzić do lepszych rezultatów, dlatego leczenie powinno być rozpoczęte, gdy wystąpią wczesne objawy, takie jak sztywność i ból przy rozpoczynaniu aktywności, nawet jeśli objawy ustępują po rozgrzaniu.

Gdy objawy utrzymują się przez 3 miesiące lub dłużej, prawdopodobieństwo poprawy stanu zdrowia bez interwencji, takiej jak terapia ruchowa, jest mniejsze.

Pierwsza linia leczenia tendinopatii ścięgna Achillesa ma charakter konserwatywny, obejmując terapię P-Dtr, ćwiczeniami, edukację oraz zarządzanie obciążeniem. Nasilenie objawów nie wpływa na początkowe leczenie, ponieważ nawet w przypadku poważnych objawów można zaobserwować znaczną poprawę dzięki podejściu konserwatywnemu.

Terapia ruchowa

Celem terapii ruchowej jest stopniowe obciążanie ścięgien, co oznacza wprowadzanie coraz większych wymagań. Istnieje wiele różnych metod, a poniżej przedstawiono kilka popularnych podejść do ćwiczeń wzmacniających stosowanych w przypadku tendinopatii. Przykład progresji programu wzmacniającego znajduje się w Ramce 2.

- **Ćwiczenia izometryczne** – ćwiczenia, w których mięśnie są napięte, lecz nie ulegają skróceniu. Ruch odbywa się poprzez staw. Ćwiczenia izometryczne mogą być pomocne w początkowej fazie radzenia sobie z bólem, ponieważ po ich wykonaniu można doświadczyć znacznej redukcji bólu. Ćwiczenia izometryczne mogą również wspierać przygotowanie do innych aktywności, które w przeciwnym razie mogłyby wydawać się zbyt niewygodne.
- **Ćwiczenia ekscentryczne** – ćwiczenia, w których jedynie faza ekscentryczna, czyli faza, w której mięsień ulega wydłużeniu i zwalnia ruch, jest obciążona. Przykładem jest ćwiczenie unoszenia pięty, w którym stajesz na palcach obu nóg, unosisz jedną nogę z podłogi, a następnie opuszczasz piętę z powrotem, stojąc na jednej nodze.
- **Ciężkie ćwiczenia oporowe (HSR)** – to rodzaj ćwiczeń, w których ruch jest wolny, a obciążenie stosunkowo duże, na przykład unoszenie pięt na maszynie do wyciskania nogami, tak aby uniesienie pięt zajmowało 3 sekundy, następnie 3 sekundy utrzymania pięt w górze i kolejne 3 sekundy opuszczenia pięt z powrotem do pozycji wyjściowej.

Jednak nie istnieje „lepszy” ani „uniwersalny” program czy podejście, a wybór ćwiczeń powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ostatecznie skuteczny program treningowy to taki, który jest systematycznie wdrażany.

Terapia P-DTR w leczeniu zapalenia ścięgna Achillesa

Terapia P-DTR (Proprioceptive Deep Tendon Reflex) to nowoczesna metoda terapii manualnej, która skupia się na przywracaniu prawidłowej funkcji układu nerwowego poprzez stymulację receptorów w tkankach ciała. W przypadku zapalenia ścięgna Achillesa, P-DTR oferuje skuteczną pomoc w łagodzeniu bólu, przywracaniu równowagi mięśniowej oraz wspomaganiu procesu regeneracji tkanek.

Podczas terapii P-DTR, terapeuta działa na układ nerwowy poprzez delikatną stymulację ścięgien, mięśni i stawów, co prowadzi do poprawy funkcji proprioceptywnych. Propriocepcja to zdolność ciała do odbierania informacji o pozycji i ruchu części ciała w przestrzeni. U osób z zapaleniem ścięgna Achillesa często dochodzi do zaburzeń w odbiorze tych sygnałów, co prowadzi do przeciążenia i bólu.

- Terapia P-DTR pomaga w resetowaniu tych nieprawidłowych wzorców, co może zmniejszyć ból oraz poprawić zakres ruchu.
- P-DTR stymuluje procesy gojenia poprzez zwiększenie przepływu nerwowego i krwionośnego w obszarze ścięgna Achillesa, co wspomaga regenerację uszkodzonej tkanki. Wykorzystanie tej metody pozwala na optymalizację wyników rehabilitacyjnych oraz zmniejszenie ryzyka nawrotów problemów z ścięgnem.

Terapia P-DTR jest skuteczną metodą wspomagającą tradycyjne podejście do leczenia zapalenia ścięgna Achillesa, takie jak fizjoterapia czy leki przeciwzapalne, oferując pacjentowi szybszy powrót do aktywności fizycznej oraz poprawę jakości życia.

„Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek ćwiczenia, warto najpierw skorzystać z terapii P-DTR. Dzięki niej można sprawdzić, czy mięśnie oraz tkanki w rejonie ścięgna Achillesa funkcjonują prawidłowo. Właściwe przygotowanie organizmu poprzez tę terapię może znacząco wspomóc dalszą aktywność fizyczną, zapewniając jej większą efektywność i bezpieczeństwo.”

Ramka 2. Przykład wzmocnienia postępu programu:

- Jeśli jest to tolerowane, program zazwyczaj rozpoczyna się od ćwiczeń wzmacniających masę ciała, takich jak unoszenie pięt, z dużą liczbą powtórzeń oporu. Jednakże, jeśli w skali od 0 do 10 ból podczas ćwiczeń lub bezpośrednio po nich przekracza 5, zaleca się kontynuowanie ćwiczeń izometrycznych, aż do poprawy tolerancji.
- Po etapie wzmacniania masy ciała z dużą liczbą powtórzeń program obejmuje ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym i mniejszą liczbą powtórzeń. Może to obejmować na przykład unoszenie pięt na maszynie do wyciskania nogami, unoszenie pięt w pozycji stojącej z hantlami lub kamizelką obciążeniową. Przed stopniowym powrotem do sportu należy również tolerować ćwiczenia plyometryczne, czyli wybuchowe ruchy o wysokiej intensywności, takie jak skakanie lub podskoki, które zwiększają moc, szybkość i zwinność poprzez trenowanie mięśni do szybszych i silniejszych skurczów.
- Tempo postępów programu zależy od odczuwanego bólu podczas ćwiczeń i po nich, a także od zmęczenia mięśni wynikającego z treningu.

A co z rozciąganiem?

Rozciąganie mięśni łydek wprowadza obciążenia kompresyjne do ścięgna Achillesa, dlatego w przypadku tendinopatii insercyjnej ścięgna Achillesa unikanie rozciągania może być korzystne w początkowej fazie. W miarę poprawy tolerancji, rozciąganie może być włączone, chociaż elastyczność stawu skokowego można również poprawić podczas ćwiczeń siłowych, co sprawia, że rozciąganie staje się opcjonalnym elementem rehabilitacji.

Zarządzanie obciążeniem oraz modyfikacja aktywności

Zarządzanie obciążeniem w tendinopatii ścięgna Achillesa polega na dostosowaniu obciążenia ścięgna w taki sposób, aby nie było ono ani zbyt duże, ani zbyt małe. Warto zauważyć, że obciążenie obejmuje również obciążenie generowane przez codzienne czynności oraz pracę, a nie tylko obciążenie wynikające z terapii ruchowej, sportu i/lub treningu.

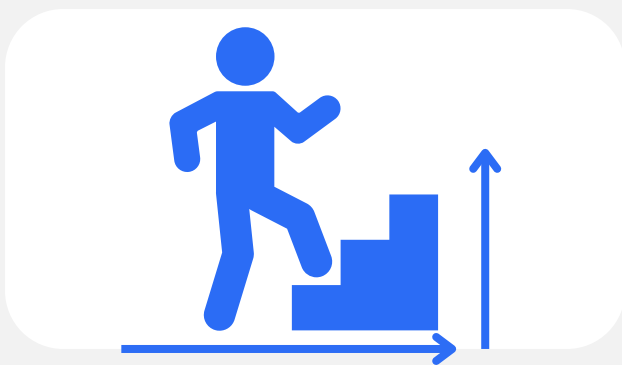
Wskazówki dotyczące zarządzania obciążeniem:

Zredukować obciążenie

Zatrzymaj lub na krótko dostosuj sporty i/lub aktywności wywołujące ból na początku, aby uniknąć bólu lub zminimalizować jego nasilenie. Nie rezygnuj całkowicie z obciążania ścięgna, lecz na przykład zastąp bolesne aktywności innymi, np. tymczasowo zamień bieganie na bieganie w wodzie, jazdę na rowerze lub spacer.

Zwiększaj obciążenie w sposób stopniowy.

Wracając do swojego sportu lub aktywności, rób to stopniowo, zwiększając obciążenie w miarę upływu czasu (rys. 2). Na przykład, jeśli jesteś biegaczem, zmień takie elementy jak dystans, częstotliwość, czas oraz prędkość biegu. W przypadku sportów zespołowych, takich jak piłka nożna, możesz dostosować obciążenie, zmieniając pozycję na boisku. Jeśli objawy były spowodowane pracą, w której musisz dużo stać, warto omówić dostępne opcje z pracodawcą oraz lekarzem.

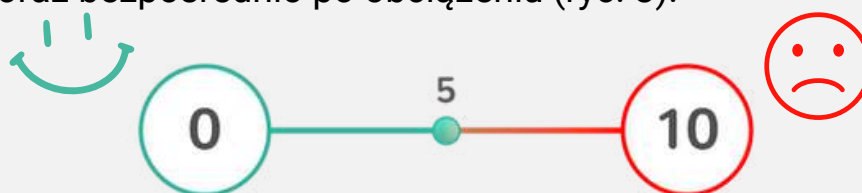


Rycina 2. Zaleca się stopniowe zwiększanie obciążenia, krok po kroku. Progresja stanowi istotny element programu terapii ćwiczeniami oraz kluczową zasadę powrotu do aktywności obciążającej ścięgna.

Monitoruj symptomy

Nie jest korzystne koncentrowanie się wyłącznie na bólu, jednak monitorowanie go oraz dostosowywanie obciążenia może być pomocne w jego kontrolowaniu. Nie oznacza to, że należy unikać bólu lub się go obawiać.

Niezależnie od zastosowanego podejścia i wybranych ćwiczeń, powszechnym zjawiskiem jest występowanie pewnego bólu i dyskomfortu w wyniku treningu. Zwiększone doznania bólowe mogą budzić niepokój, a nawet strach, co może prowadzić do unikania aktywności fizycznej. Należy jednak pamiętać, że obciążenie ścięgien jest kluczowe dla procesu regeneracji, a pewien poziom bólu jest normalny zarówno w trakcie, jak i po ćwiczeniach. Ogólnie zaleca się, aby ból nie przekraczał 5 w skali od 0 do 10 podczas oraz bezpośrednio po obciążeniu (ryc. 3).



Rycina 3. W skali od 0 do 10 dąż do utrzymania bólu na poziomie 5 lub niższym podczas oraz bezpośrednio po czynnościach obciążających ścięgna i ćwiczeniach, chyba że z fizjoterapeutą ustalono inny zakres.

Alternatywne opcje?

W niektórych przypadkach trzy miesięczny program terapii ćwiczeniami, obejmujący stopniowe wzmacnianie oraz zarządzanie obciążeniem, może okazać się niewystarczający do wykazania jakichkolwiek postępów. W takich sytuacjach można rozważyć zastosowanie dodatkowych terapii wspomagających. Wybór tych metod leczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i zazwyczaj łączy się z kontynuacją terapii ćwiczeniami oraz działaniami w zakresie zarządzania obciążeniem. Przykłady takich dodatków obejmują terapię falą uderzeniową pozaustrojową, terapie iniekcyjne oraz inne pasywne metody, takie jak masaż.

Ogólne samopoczucie zdrowotne

Na ból oddziałują różnorodne czynniki wykraczające poza zmiany tkankowe, a jego intensywność może nie być skorelowana ze zmianami strukturalnymi. Elementy takie jak sen, stan emocjonalny oraz indywidualne przekonania dotyczące bólu mogą wpływać na Twoje doświadczenie. W związku z tym zaleca się skoncentrowanie na ogólnej samoopieki oraz zajęcie się czynnikami metabolicznymi związanymi z tendinopatią ścięgna Achillesa.

Czucie się przygnębionym lub zestresowanym z powodu swojego stanu jest zjawiskiem powszechnym, ponieważ może ograniczać uczestnictwo w ulubionych aktywnościach oraz wywoływać poczucie niepewności. Zajmij się tymi emocjami, gdy się pojawią.

Jeśli obawa przed pogorszeniem sytuacji prowadzi do unikania ćwiczeń progresywnych, skonsultuj się z personelem medycznym, ponieważ unikanie może utrudniać proces zdrowienia. Nie wahaj się poprosić swojego pracownika służby zdrowia o dodatkowe informacje na temat poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz innych zachowań prozdrowotnych.

Lek

Należy przyznać, że stosowanie leków przeciwzapalnych (NLPZ) wydaje się być mało skuteczne i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza w miarę starzenia się. Iniekcje kortykosteroidów również nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w przypadku tendinopatii ścięgna Achillesa w jego środkowej części, mogą prowadzić do długotrwałych negatywnych skutków oraz stwarzać problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zwiększone ryzyko pęknięcia ścięgna, szczególnie przy wielokrotnych iniekcjach. W związku z tym należy zachować ostrożność przy rozważaniu stosowania NLPZ oraz zastrzyków kortykosteroidów.

Ciepło i zimno stanowią stosunkowo bezpieczne alternatywy, dlatego warto sprawdzić, czy przynoszą ulgę w łagodzeniu objawów bólu.

Jak zapobiegać (ponownemu) wystąpieniu problemu?

- Nie spiesz się. Poświęć odpowiednią ilość czasu na aktywne radzenie sobie z chorobą, zanim powrócisz do aktywności, które wywołały ból.
- Unikaj „skoków obciążenia” i przygotuj się na rosnące wymagania treningowe oraz aktywności, stopniowo budując swoją odporność.
- Oprócz obciążania ścięgna, zadbaj o odpowiednią ilość odpoczynku i regeneracji.
- W chłodniejszych porach roku noś wystarczającą ilość odzieży, aby się ogrzać (w tym również w okolicy kostek).
- Rozważ dążenie do lub utrzymanie zdrowej masy ciała.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów.

